Клинические рекомендации

Воспалительные заболевания челюстей у детей

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**K10.2** — Воспалительные заболевания челюстей **M86** — Остеомиелит
Пациенты	дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 24.12.2025, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	ООО «Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии»
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/997_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 2

2. Клиническая картина и классификация 2

2.1 Определения 2

2.2 Этиология и эпидемиология 3

2.3 Классификация 3

2.4 Клиническая картина 4

3. Диагностика 4

3.1 Критерии диагноза первично-хронического остеомиелита 4

3.2 Жалобы и анамнез 5

3.3 Осмотр полости рта и челюстно-лицевой области 5

3.4 Биопсия 5

3.5 Лабораторные исследования: анализы крови и посев 5

3.6 Компьютерная томография челюстно-лицевой области 6

3.7 УЗИ мягких тканей и лимфоузлов шеи 6

4. Лечение 6

4.1 Антибактериальная терапия 6

4.2 Дополнительная терапия 7

4.3 Хирургическое лечение 8

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 8

5.1 Показания к госпитализации 8

5.2 Профилактика и реабилитация 9

6. Источник и актуальность 9

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 9

1. Основные положения

- Хронический остеомиелит челюсти — гнойное деструктивное или пролиферативное воспаление кости **более 4 недель** с образованием секвестров или без тенденции к выздоровлению. Различают первично-хронический (негнойный), вторично-хронический (гнойный) остеомиелит и продуктивный периостит.
- Диагноз первично-хронического остеомиелита устанавливают при наличии 2 больших или 1 большого и 3 малых критериев. Для исключения сарком и фиброзно-костных поражений выполняется биопсия.
- При обострении вторично-хронического остеомиелита антибиотик широкого спектра назначают эмпирически с первых часов госпитализации, эффект оценивают **через 2–3 дня** и корректируют терапию по результатам посева. Поднадкостничный абсцесс вскрывают внутриротовым доступом, флегмону вскрывают и дренируют наружным доступом.
- Основным методом лечения вторично-хронического остеомиелита является хирургический: секвестрэктомия или резекция челюсти, которые выполняют только после формирования секвестральной полости и полного отграничения секвестра.
- Показания к экстренной госпитализации:
  1. обострение при суб- или декомпенсированных сопутствующих заболеваниях, гиперергическом течении, опухолях, иммунодефиците;
  2. невозможность операции под местной анестезией;
  3. отсутствие стоматолога-хирурга.

  Плановая госпитализация показана при хроническом остеомиелите со сформированным секвестром, а также при затяжном, торпидном или прогрессирующем течении.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

Остеомиелит — воспалительное состояние костной ткани различной природы, которое начинается с медуллярной полости, быстро распространяется по системе гаверсовых каналов, вовлекая в воспаление надкостницу и прилегающие мягкие ткани.

Периостит — воспалительное заболевание, вовлекающее надкостницу альвеолярного отростка и тела челюсти из одонтогенного или неодонтогенного очага.

Секвестр — отграниченный воспалительно-некротический очаг костной ткани, располагающийся более или менее свободно и не подвергающийся аутолизу.

Зубоальвеолярный сегмент — условная единица объёма альвеолярной части челюсти для оценки распространённости воспаления; верхняя граница сегментов верхней челюсти — дно полости носа и верхнечелюстных пазух.

Симптом Венсана — снижение чувствительности кожи над поражённым участком и (или) нижней губы.

Формы хронического воспаления челюстей

1. **первично-хронический остеомиелит (негнойный)**: фиброзно-костное продуктивное заболевание без выявленного триггера, без гноя, свищей и секвестров, с упорно-рецидивирующим течением и избыточным образованием кости;
2. **вторично-хронический остеомиелит**: гнойное деструктивное или пролиферативное воспаление **более 4 недель**, связанное с одонтогенной инфекцией, инородными телами, травмой, пороком развития кости или системными заболеваниями;
3. **хронический периостит челюсти**: хронический одонтогенный процесс с вовлечением надкостницы, который может выходить за пределы пародонта одного зубоальвеолярного сегмента;
4. **хронический рецидивирующий мультифокальный остеомиелит**: неинфекционное многоочаговое литическое поражение костей; у взрослых ему соответствует синдром SAPHO (синовит, акне, пустулёз, гиперостоз, остеит).

2.2 Этиология и эпидемиология

Первично-хронический остеомиелит — небактериальное хроническое воспалительное заболевание неизвестной этиологии, которое может быть связано с другими состояниями, включая аутоиммунные заболевания и синдромы. В настоящее время преобладает генетическая теория; в большинстве случаев посевы удалённых фрагментов челюстей стерильны.

Вторично-хронический остеомиелит возникает в результате внедрения микроорганизмов в челюсть при травме или одонтогенной инфекции, чаще всего стоматологического происхождения (заболевание пульпы, удаление зуба, инородные тела). На неспорообразующие анаэробы приходится 65–75% микрофлоры.

Продуктивный периостит чаще всего развивается как осложнение хронического периодонтита (74,6%), поражение при этом обычно располагается в области первого коренного зуба.

Хронические негнойные формы встречаются с частотой 1–2 на 1 000 000; первично-хронический остеомиелит у девочек в 4 раза чаще, средний возраст 9–10,8 года. Продуктивный периостит чаще у мальчиков, дебют в 8,8–11 лет. Чаще поражается нижняя челюсть.

2.3 Классификация

По течению

1. первично-хронический: ювенильный продуктивный, синдром-ассоциированный (SAPHO, синдром Маджида, DIRA, PAPA);
2. вторично-хронический: одонтогенный, неодонтогенный (неонатальный, травматический, от инородного тела, при мальформации сосудов);
3. продуктивный периостит: простой, оссифицирующий (остеомиелит Гарре), посттравматический.

По этиологии

1. гнойный: специфический (туберкулёзный, актиномикозный), неспецифический (бактериальный, грибковый);
2. негнойный: остеорадионекроз, медикаментозный, аутоиммунный.

По локализации

1. верхняя или нижняя челюсть;
2. локальный: зубоальвеолярный сегмент, альвеолярная часть, базис, ветвь;
3. распространённый: тотальный, субтотальный.

Острый остеомиелит отличается от хронического длительностью **менее 4 недель** от появления симптомов.

2.4 Клиническая картина

Первично-хронический остеомиелит протекает с обострениями (от нескольких дней до недель) и ремиссиями (от нескольких месяцев до нескольких лет). Поражение челюсти чаще наблюдается у девочек, как правило, унифокально; возраст дебюта около 10 лет (4–14 лет).

Симптомы при поражении нижней челюсти

1. боль, часто усиливающаяся ночью, с лихорадкой или без;
2. ограничение открывания рта, отёк;
3. регионарная лимфаденопатия;
4. парестезия над очагом и (или) нижней губы.

Гной, свищи и секвестры отсутствуют, что отличает его от острого и вторично-хронического остеомиелита. При тяжёлом течении исключают злокачественные новообразования, прежде всего острый лимфобластный лейкоз.

Около 25% пациентов имеют кожные (псориаз, ладонно-подошвенный пустулёз, акне) и кишечные заболевания (болезнь Крона, язвенный колит); при поражении челюсти, ключицы, грудины возможны бессимптомные очаги в скелете.

Вторично-хронический остеомиелит характеризуется гноем, свищами и секвестрами, течёт с обострениями.

Местные проявления

1. свищевые ходы до кости с гноем или грануляциями;
2. абсцессы и флегмоны при обострении;
3. ограничение открывания рта при поражении угла и ветви нижней челюсти;
4. подвижность зубов в очаге.

Продуктивный периостит проявляется односторонним безболезненным плотным утолщением задних двух третей нижней челюсти с умеренной асимметрией лица, без признаков воспаления кожи и слизистой оболочки; толщина нароста до 2–3 см. Иногда возможны свищ и лимфаденопатия.

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза первично-хронического остеомиелита

Критерии диагноза первично-хронического остеомиелита

Большие критерии	Малые критерии
рентгенологически подтверждённые остеолитические и остеосклеротические очаги	хорошее общее состояние и нормальная лейкоцитарная формула
множественные очаги поражения	СОЭ и С-реактивный белок незначительно повышены
псориаз или ладонно-подошвенный пустулёз	длительность заболевания более 6 месяцев
стерильная биопсия с признаками воспаления и (или) фиброза, склероза	гиперостоз

Большие критерии	Малые критерии
—	связь с другими аутоиммунными заболеваниями; аутоиммунные и аутовоспалительные заболевания у родственников I и II линии

Для постановки диагноза необходимы 2 больших или 1 большой и 3 малых критерия.

3.2 Жалобы и анамнез

Сбор жалоб и анамнеза проводит челюстно-лицевой хирург или стоматолог-хирург.

Основные жалобы

1. боль в зубе или челюсти, иррадиация по ветвям тройничного нерва;
2. подвижность зубов, отёк мягких тканей;
3. парестезия нижней губы и подбородка;
4. ограничение открывания рта, боль при глотании, жевании, движениях языка;
5. свищи, деформация челюстей;
6. симптомы интоксикации.

Уточняют связь с заболеванием или удалением зуба, переохлаждением, простудой, перенапряжением; динамику и проведённое лечение.

3.3 Осмотр полости рта и челюстно-лицевой области

Оценка общего состояния: визуальный осмотр, термометрия, пальпация костной системы, осмотр полости рта и челюстно-лицевой области при обострении.

Клиническая оценка мягких тканей, регионарных лимфоузлов и полости рта: пальпация, перкуссия, степень открывания рта и подвижности нижней челюсти. Определяется изменение конфигурации лица за счёт инфильтрации и периостального утолщения; кожа над утолщением не изменена.

3.4 Биопсия

Биопсия из очага выполняется для дифференциальной диагностики с фиброзно-костными поражениями и остеосаркомами, поскольку на ранних этапах их клиническая картина сходна с хроническим остеомиелитом.

Материал, полученный при операции, направляют на патологоанатомическое исследование для дифференциальной диагностики с невоспалительными поражениями и специфическим воспалением.

3.5 Лабораторные исследования: анализы крови и посев

Общий анализ крови позволяет оценить выраженность воспаления. При обострении вторично-хронического остеомиелита выявляется лейкоцитоз более $10 \cdot 10^9$/л, нейтрофилы до 70–80%; СОЭ повышается до 40 мм/ч при гиперергии или остаётся в норме при гипоергии.

Уровень С-реактивного белка отражает динамику воспаления и необходимость коррекции терапии; при хронических формах его повышение умеренное и неспецифичное.

Всем пациентам с подозрением на воспалительное заболевание челюсти выполняется посев гноя, отделяемого свищей и ран с определением чувствительности. Материал биопсии и вскрытия абсцесса обязательно направляют на посев.

3.6 Компьютерная томография челюстно-лицевой области

КТ выполняется для определения распространённости и типа процесса и планирования лечения, в том числе при обострении.

Диагностические признаки

1. первично-хронический остеомиелит: на ранней стадии изменений может не быть, позже выявляется смешанная картина склероза и остеолиза, периостальная реакция, «кость на кости»; секвестры крайне редки;
2. вторично-хронический остеомиелит: очаги деструкции с секвестрами и участками остеосклероза; секвестр отграничивается **на 4–6-й неделе** на верхней челюсти и **на 6–8-й неделе** на нижней;
3. продуктивный периостит: слоистые периостальные наслоения по типу «луковой шелухи» над компактной костью в области причинного зуба.

3.7 УЗИ мягких тканей и лимфоузлов шеи

УЗИ мягких тканей, костей челюстно-лицевой области и лимфатических узлов шеи применяют для оценки гнойного процесса и дифференциальной диагностики с абсцессами, артритами и опухолями.

---

4. Лечение

Основные компоненты лечения

1. хирургическое лечение: санация очага, удаление причинного зуба, вскрытие и дренирование абсцесса;
2. общая и местная противомикробная терапия;
3. патогенетическое и симптоматическое лечение.

Лечение первично-хронического остеомиелита

1. первая линия: санация полости рта, НПВП;
2. вторая линия: плоскостная резекция очага, антибиотики, системные глюкокортикоиды, бисфосфонаты, ингибиторы ФНО-альфа или интерлейкинов.

4.1 Антибактериальная терапия

При выявлении инфекционной причины проводится рациональная антибактериальная терапия по результатам посева; шаблонное применение антибиотиков недопустимо. При первично-хроническом остеомиелите антибиотики неэффективны.

При обострении вторично-хронического остеомиелита антибиотик широкого спектра начинают эмпирически с первых часов в стационаре, эффект оценивают **через 2–3 дня**, затем корректируют по посеву. Средняя длительность терапии составляет **5–10 дней**.

Критерии достаточности антибактериальной терапии

1. стойкая нормализация температуры;
2. положительная динамика основных симптомов;
3. нет признаков системной воспалительной реакции;
4. нормализация лейкоцитов, формулы, СОЭ, СРБ;
5. отрицательная гемокультура;
6. нормализация функции ЖКТ.

Сохранение только одного признака бактериальной инфекции (лихорадка или лейкоцитоз), а также гранулирующая рана не являются абсолютным показанием к продолжению антибактериальной терапии.

При стабилизации общего состояния, переходе местного гнойного процесса во II фазу, положительной динамике или нормализации лабораторных показателей системные антибиотики отменяют, и в дальнейшем акцент переносят на местное применение антисептиков.

При отсутствии стойкого ответа на адекватную терапию **в течение 1–3 дней** необходимо дополнительное обследование (УЗИ, КТ, посевы) для поиска осложнений и вторичного очага.

При отягощённом соматическом статусе продолжительность антибактериальной терапии увеличивают; при выделении S. aureus или P. aeruginosa с бактериемией её проводят **не менее 14 суток**.

Другие показания к продлению антибактериальной терапии

1. воспаление в труднодоступных локусах: клапаны сердца, ЦНС, кости, предстательная железа;
2. сохраняющаяся нейтропения;
3. невозможность одномоментной хирургической санации и дренирования первичного или вторичных очагов;
4. воспаление, вызванное поли- и панрезистентными микроорганизмами.

4.2 Дополнительная терапия

При обострении проводится дезинтоксикационная инфузионная терапия сбалансированными растворами.

Гипербарическую оксигенацию допустимо применять только как вспомогательный метод из-за высокой частоты рецидивов и опасных осложнений.

При хроническом небактериальном остеомиелите для купирования боли применяют НПВП (эффективны у 40–80% детей): #метамизол натрия, парацетамол, ибупрофен, #кетопрофен.

При первично-хроническом остеомиелите системные глюкокортикоиды назначают при неэффективности НПВП, а также при рецидивирующем или тяжёлом течении.

1. преднизолон: 2 мг/кг в сутки внутрь **1 неделю** с последующим снижением дозы на 25% каждые 5 дней.

При упорно рецидивирующем течении возможно применение внутривенных форм.

Для достижения стойкой ремиссии хронического остеомиелита применяют препараты, влияющие на минерализацию кости (бисфосфонаты).

1. #памидроновая кислота: 1 мг/кг (максимум 60 мг) ежемесячно или 1 мг/кг 3 дня подряд каждые 3 месяца.

4.3 Хирургическое лечение

Принципы хирургического лечения

1. вскрытие гнойного очага и удаление причинного зуба;
2. выбор обезболивания совместно с анестезиологом;
3. кратчайший доступ к очагу с наименьшим риском повреждения сосудов и нервов и лучшим оттоком.

При первично-хроническом остеомиелите выполняют биопсию кости в объёме декортикации очага, что улучшает доступ препаратов в очаг.

При продуктивном периостите устраняют источник инфекции (удаление или лечение зуба, вскрытие абсцесса) или травмы, иссекают изменённую надкостницу и избыточную кость.

При обострении поднадкостничный абсцесс вскрывают внутриротовым доступом (периостотомия); при флегмоне или свище выполняют вскрытие и дренирование наружным доступом.

При вторично-хроническом остеомиелите выполняют секвестрэктомию или резекцию челюсти в пределах неизменённой кости. Операцию проводят только после формирования секвестральной полости и полного отграничения секвестра (по данным КТ, на верхней челюсти **на 4–6-й неделе**, на нижней **на 6–8-й неделе**).

На верхней челюсти используют внутриротовой доступ. При осложнении верхнечелюстным синуситом или секвестрации стенок пазухи секвестрэктомию выполняют по типу радикальной операции на верхнечелюстной пазухе (по Колдуэллу — Люку).

При рарефицирующем периостите и гиперпластической форме хронического остеомиелита показано оперативное вмешательство: вскрытие и дренирование флегмоны или абсцесса в костной ткани, некрэктомия и выскабливание грануляций.

Гнойный очаг дренируют (дренаж Пенроуза, силиконовые дренажи) и проводят местное лечение раны по фазам: в I фазе применяют антисептики, во II фазе средства, стимулирующие репарацию.

Антисептики в I фазе раневого процесса (орошения, инстилляции, внутрикостный лаваж ежедневно)

1. хлоргексидин: 0,02% и 0,05% раствор;
2. бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмоний: 0,01% раствор;
3. #повидон-йод: 10% раствор в разведении в 10 или 100 раз, 7,5% раствор.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Экстренная госпитализация

1. обострение при суб- или декомпенсированных сопутствующих заболеваниях, гиперергическом течении, опухолях, иммунодефиците;
2. невозможность операции под местной анестезией (поведение ребёнка, сопутствующая патология, аллергия на анестетики);
3. отсутствие стоматолога-хирурга.

Плановая госпитализация

1. хронический остеомиелит со сформированным секвестром;
2. затяжное, торпидное или прогрессирующее течение с длительным формированием секвестров.

Пациента выписывают при неосложнённом раннем послеоперационном периоде, удовлетворительном состоянии, контролируемой боли и возможности продолжить антибиотики амбулаторно под наблюдением челюстно-лицевого хирурга.

5.2 Профилактика и реабилитация

Основой профилактики является санация полости рта.

1. осмотр стоматолога-терапевта и стоматолога-хирурга: не реже 1 раза в год;
2. профессиональная гигиена: не реже 1 раза в 6 месяцев;
3. осложнённый кариес: своевременное эндодонтическое лечение.

Физиотерапию (электрофорез, ультразвук, парафин) применяют после адекватного хирургического лечения, ЛФК — в период ремиссии.

Факторы риска рецидива

1. возраст **6–12 лет** (смешанный прикус);
2. лейкоцитоз более $15 \cdot 10^9$/л и температура выше 39 °C при поступлении;
3. MRSA-инфекция (риск выше в 4 раза);
4. предшествующее введение антибиотиков;
5. диабет.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Воспалительные заболевания челюстей»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 24.12.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее декабря 2028 года
Код в рубрикаторе	997_1 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии
Пациенты	Дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Клинически значимых расхождений в тексте рекомендации при сверке не найдено.